



3

57. ÅRGANG | 03 • 2020

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Tema

Artikler fra forskning og praksis

PPT nr. 3-2020

**Behandling af børn og unge med
seksuelt bekymrende adfærd
med nedsat funktionsniveau ved
hjælp af netværksforløb**

Af Vanessa Anna Schmidt-Rasmussen

Behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd med nedsat funktionsniveau ved hjælp af netværksforløb



Det kan være vanskeligt for professionelle, som arbejder med børn og unge at forholde sig til seksuelle problemstillinger, hvor de er nødt til at bedømme bekymringsgraden og vurdere handlemulighederne. Udfordringen opleves ofte større, når der er tale om børn med neuropsykiatriske vanskeligheder og udviklingshæmning. Artiklen beskriver faktorer, der øger risikoen for recidiv overgrebsadfærd hos børn og unge, samt vigtigheden af, at barnets omsorgspersoner og netværk inddrages i behandlingen. Dernæst beskrives netværksforløb - en særlig behandlingsmetode, der er udviklet netop til at hjælpe børn og unge med nedsat funktionsniveau, som udviser seksuelt grænseoverskridende adfærd. Metoden involverer barnets/den unges netværk, som både kan bestå af forældre og professionelle, deriblandt PPR. Artiklen skildrer JanusCentrets erfaringer fra behandlingsarbejdet med denne gruppe børn og unge med beskrivelse af konkrete øvelser og cases, samt PPRs involvering og muligt udbytte.

Af Vanessa Anna Schmidt-Rasmussen, autoriseret psykolog og tidligere ansat ved JanusCentret, fra den 1. April 2019 Børnehus Hovedstaden.

Seksuelt bekymrende adfærd hos skoleelever

Flere professionelle oplever, at det kan være vanskeligt at skelne mellem normativ og bekymrende seksuel adfærd hos børn og unge. Der skal tages flere faktorer i betragtning som alder, adfærdens karakter og hensigt (Januscentret, 2016, ¶Bekymringsbarometer). Hvad der opleves som en almindelig udtalelse fra en 15-årig, kan være yderst bekymrende, hvis det observeres hos et yngre barn. Dette gør sig især gældende, når der opleves normskred i forhold til, hvad der anses for at være almindelig adfærd både af de

unge og voksne. Det er nemmere at irettesætte en elev, hvis adfærd betydeligt afviger fra de andres. Det forekommer derimod ofte, at børn og unge imiterer hinandens adfærd og kan tilvænne sig u hensigtsmæssige adfærdsmønstre, som kan være svære at bryde, hvis de forbliver i samme miljø (Worling & Långström, 2003). Ligesom det ofte forekommer, at brugen af bandeord hurtigt spredes i en klasse, kan seksualiserende sprog og adfærd følge samme mønster. Det er ikke alene børn og unge, der kan få svært ved at vurdere, hvad der egentlig ikke hører til i deres hverdag. Voksne og professionelle

kan også vænne sig til den uhensigtsmæssige adfærd, som derfor ikke længere opfattes som bekymrende, for kan og bør man korrigere noget, som "alle unge gør"? Grænseoverskridende sprog og adfærd kan ses som en del af kulturen på skolen, der inspireres af, hvad der ses i medierne. Det er her vigtigt at huske, at grænseoverskridende adfærd ikke bliver mindre bekymrende af, at der er flere, der udviser den. Snarere tværtimod. De unge er derfor afhængige af de professionelle og deres rolle i forhold til at korrigere og fastholde forskellen på normativ og bekymrende adfærd. Børn og unge med særlige vanskeligheder er i endnu større grad afhængige af de professionelles hjælp til at hjælpe dem med at overholde egne og andres grænser (Red Barnet, 2015).

Hvornår bør personalet blive bekymret

De professionelle bør altid reagere på adfærd, hvor nogen oplever, at deres grænser er blevet overtrådt. Det er vigtigt at se efter elementer af pres, tvang, trusler, misbrug af social status samt viden og adfærd, der overstiger det forventelige for børnenes/de unges aldersgruppe (Januscentret, 2016, ¶ Bekymringsbarometer). Den professionelles vurdering bør ikke alene hvile på børnenes/de unges oplevelse, men også i høj grad basere sig på den faglige viden om seksualitet og grænser. Det er nemlig ikke altid, at børn og unge vil, eller kan give udtryk for, at deres grænser er blevet overskredet. Der kan blandt andet være tale om unge, som er bange for at opleve negative sociale konsekvenser, hvis de siger fra over for

grænseoverskridende adfærd, børn og unge, som er blevet truet til hemmeligholdelse (Januscentret, 2018), eller børn og unge, som ikke i tilstrækkelig grad kan mærke deres grænser.

Lærerne, pædagoger og andet skolepersonale spiller en afgørende rolle både som observatører og handlende aktører i forhold til at hjælpe med at stoppe den uhensigtsmæssige adfærd, da en stor andel af overgreb sker i skolen eller dag- og døgninstitutioner (Januscentret, 2018).

Det er vigtigt, at de professionelle ikke går alene med bekymringen om et barn/ung eller en gruppe, der udviser seksuelt bekymrende adfærd. En beredskabsplan, der beskriver, hvordan man bør handle ved tilfælde af bekymring og tvivl, bør i disse tilfælde tages i brug. Det vil ofte være relevant for skolepersonalet at drøfte deres betragtninger med ledelsen, og der bør tages stilling til, om bekymringen skal lede til en underretning til forvaltningen eller, om der skal søges vejledning hos PPR.

PPRs rolle

Skolepersonale kan henvende sig, eller blive vejledt til at henvende sig til PPR for at få hjælp til at vurdere sagens alvor. PPR kan her blive stillet over for en opgave med særlig kompleksitet, som kræver en afvejning i forhold til, hvor meget det seksuelle fylder i forhold til barnets/den unges andre vanskeligheder. Er den seksuelle problematik en direkte forlængelse af barnets udviklingsmæssige vanskeligheder, bliver den forstærket af dem, eller er der tale om helt andre udløsende faktorer? Den rigtige forståelse af ad-

færdens baggrund har afgørende betydning i forhold til at iværksætte den rette foranstaltning. PPR kan derfor blive inddraget meget tidligt i processen for at hjælpe med at vurdere den bekymrende adfærd og for at rådgive skolepersonalet i forhold til handlemuligheder.

Det er ligeledes muligt, at PPR bliver opmærksom på en seksuelt grænseoverskridende problematik på baggrund af en anden bekymring. Personalet kan ønske en pædagogisk psykologisk udredning eller konsultativ bistand på grund af barnets/den unges sociale vanskeligheder på skolen, eller mistrivsel, hvor der ikke lægges vægt på det seksuelle. Selv når der ikke lægges fokus på det seksuelle, er det relevant at overveje, om der er grund til bekymring i forhold til barnets/den unges seksuelle udvikling og adfærd, da denne går hånd i hånd med barnets/den unges sociale udvikling (Kar, Choudhury & Singh, 2015). Opleves den unge meget dominerende og truende, er der risiko for, at dette også kan komme til udtryk på den seksuelle arena. Det kan derfor være vigtigt for PPR at spørge ind til seksuelt grænseoverskridende adfærd og medtage det i sin rådgivning af skolepersonalet.

Hvordan skal man forholde sig til børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd med nedsat funktionsniveau

Børn og unge med neuropsykiatriske vanskeligheder og udviklingshæmning har endnu stærkere behov for hjælp og guidning i forhold til deres seksuelle udvikling (Holt et al. 2017). Det er vigtigt at understrege, at det langt fra er

alle børn og unge med diagnoser og udviklingshæmning, der udviser seksuelt grænseoverskridende adfærd. Vanskeligheder forbundet med diagnoser og udviklingshæmning kan dog gøre den gruppe børn og unge mere udsat i forhold til at overse vigtige signaler i sociale samspil, som kan føre til grænseoverskridende adfærd (Januscentret, 2017). De kan desuden have svært ved at danne sig overblik og vil ofte have behov for flere gentagelser og særligt tilpassede forklaringsmodeller for at indlære reglerne for normativ seksuel adfærd.

Dialog omkring det seksuelle med den gruppe børn og unge er af afgørende betydning, ikke kun for at forhindre, at de kommer til at overtræde andres grænser, men også, da de selv er særlig udsatte i forhold til selv at blive udsat for krænkende adfærd (Red Barnet, 2015). Der kan derfor argumenteres for, at denne gruppe særligt udsatte børn og unge kræver særlig professionel omsorg også med henblik på den seksuelle udvikling.

Professionelle som arbejder med børn og unge, som ikke har alderssvarende funktionsniveau, konfronteres ofte med en problemstilling, hvor de skal forholde sig til barnets/den unges biologiske alder versus funktionsalder. Dette giver anledning til spørgsmål blandt andet omkring acceptabel aldersforskel mellem kæresten og til generel seksuel adfærd. Bør man acceptere, at en 16-årig, der har en kognitiv alder svarende til 9 år, har en 11-årig kæreste? Er det i orden, at en 10-årig med en funktionsevne svarende til 4 år blotter sig foran andre, eller spørger nysgerrigt til andres kønsorganer? Dis-

se er blot få af mange dilemmaer, som de professionelle er nødt til at forholde sig til og illustrerer, hvorfor arbejdet med denne gruppe unge kræver særlig viden og kompetencer på området.

Ekspertviden – JanusCentret

JanusCentret er et udrednings- og behandlingstilbud til børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer samt deres ofre og familier. Seksuelle adfærdsproblemer omfatter både seksuelt krænkende adfærd, seksuelle overgreb, uhensigtsmæssig seksualiserende adfærd på internettet, samt adfærd der gør barnet/den unge særlig udsat i forhold til at få egne seksuelle grænser overskredet.

JanusCentret tilbyder både udredning med psykologisk undersøgelse og seksuel udredning af de henviste børn/unge. Der er mulighed for at udvide udredningen med en traumescreening eller risikovurdering af recidiv overgrebsadfærd. Udover udredning tilbyder JanusCentret forskellige typer behandling, samt supervision, formidling og rådgivning. JanusCentret er desuden det nationale videns- og forskningscenter i forhold til målgruppen samt VISO-leverandør (JanusCentret, 2018).

Behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd

Litteraturen skildrer, at gruppen af børn og unge med seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd er mangfoldig og der findes ikke én profil, som beskriver hele gruppen, men snarere flere typer unge, som på baggrund af forskelligartede problematikker udviser seksuelt grænseoverskridende ad-

færd (Worling, 2001). En grundig udredning er derfor afgørende for at kunne iværksætte effektive hjælpeforanstaltninger.

Undersøgelser af unge, som har begået seksuelle overgreb, fremhæver en række faktorer, som øger risikoen for recidiv overgrebsadfærd (Worling & Långström 2003). Professionelle, som arbejder med børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd bør kende disse og medtænke dem i deres arbejde for at kunne tilbyde den bedste hjælp og støtte.

Blandt risikofaktorer nævnes blandt andet seksuel interesse i præpubertære børn og interesse i seksuel vold (Worling & Curwen, 2000). Ifølge Hunter og Lexier (1998 in Worling 2001) er seksualitet hos unge, der har begået seksuelle krænkelser mere omskiftelig, hvad angår seksuelle præferencer. Ofrets køn og alder afspejler derfor ikke nødvendigvis den krænkende parts seksuelle præferencer (Worling, 2001). Man bør derfor i arbejdet med unge, der begår seksuelle krænkelser, være forsigtig med at antage, at de er seksuelt tiltrukket af yngre børn, samt at de altid vil rette deres seksualitet imod denne gruppe. Viser det sig, at de er seksuelt tiltrukket af yngre børn, er der øget risiko for, at de vil begå flere seksuelle overgreb mod børn (Worling & Curwen, 2000).

En anden væsentlig risikofaktor i forhold til gentagne seksuelle grænseoverskridelser, der fremhæves i internationale undersøgelser, er social isolation og begrænset social kontakt (Långström & Grann, 2000; Lane 1997; Epps 1997 in Worling & Långström 2003). Det er vigtigt, at beskrivelsen af

barnets/ den unges netværk og eventuel identificering af social isolation sker med inddragelse af netværket, da det lader til, at det er svært for unge at indrømme, at de er socialt isolerede (Worling & Långström 2003).

Relationen til forældre lader også til at have en effekt, hvor en konfliktfyldt relation til forældre og følelsen af at være afvist af dem øger risikoen for recidiv, mens tæt relation til forældre mindsker risikoen for tilbagefald (Lipsey & Derzon, 1998; Lane, 1997).

Risikoen for flere seksuelle grænseoverskridelser er ligeledes højere hos unge, som tilskriver ofret skylden, og som mangler forståelsen af, at seksuelle overskridelser er skadelige og forkerte (Kahn & Chambers, 1991; Calder et al., 1997, Epps, 1997; Perry & Orchard, 1992).

Internationale undersøgelser peger på, at omsorgsgiveres deltagelse i behandlingsforløbet spiller en væsentlig rolle i forhold til at mindske seksuelt bekymrende adfærd hos børn og unge (Amand, Bard & Silovsky, 2008). Deres deltagelse er vigtig blandt andet i forhold til at drøfte seksuelle regler og giver netværket mulighed for en bedre forståelse af barnets/unges vanskeligheder samt forhold, som de skal være særligt opmærksomme på.

På baggrund af den ovennævnte nationale og internationale forskning kan det konkluderes, at en effektiv behandlingsindsats for børn/unge med nedsat funktionsniveau, som udviser seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd bør tage udgangspunkt i en grundig udredning af barnets/ den unges psykosociale funktionsniveau og seksuel anamnese. Effektiv behandling til denne mål-

gruppe bør ligeledes arbejde med risikofaktorer, som øger sandsynligheden for recidiv overgrebsadfærd, samt inddrage barnets/ den unges netværk.

Den nationale forskning peger på, at børn og unge med neuropsykiatriske vanskeligheder og udviklingshæmning er overrepræsenteret i forhold til gruppen, som henvises til udredning og behandling for seksuelt grænseoverskridende adfærd (JanusCentret, 2018). Det anses derfor for yderst relevant, at de tilbydes hjælp, som de kan profitere af og som bygger på metoder, der understøttes videnskabeligt.

Det er netop med henblik på denne gruppe, at JanusCentret har udarbejdet netværksforløbet. Følgende beskriver denne behandlingsmodel samt praksiserfaringer fra arbejdet med netværksforløb.

Beskrivelse af netværksforløb

Netværksforløb er en overgrebsforebyggende behandlingsmetode til børn og unge, der udviser seksuelt krænkende og eller bekymrende adfærd. Det særlige ved netværksforløbet er, at metoden ikke blot fokuserer på barnet/ den unge, men i høj grad søger at opkvalificere klientens netværk. Dette gøres for at sikre, at den opnåede viden og de redskaber, der anvendes i behandlingen, kan videreføres til barnets/ den unges hverdag. Metoden er derved mindre følsom i forhold til barnets/ den unges egen evne til at omsætte den generelle viden til specifik adfærd. Netværket har ligeledes mulighed for at motivere barnet/ den unge til at fortsætte behandlingen og bruge de erhvervede redskaber i hverdagen (JanusCentret, 2015).

For at møde de kliniske mål består netværksforløb af:

- en undervisningsgang til netværket
- 6 supervisionsgange til netværket
- 8 behandlingsgange, hvor barnet/den unge deltager sammen med sit netværk
- Afsluttende møde og statusudtalelse med anbefalinger til fremtidig indsats

Undervisning

Undervisningsdelen tager afsæt i den unge, som skal indgå i netværksforløb, men efterlader plads til mere generaliseret viden på området som risikofaktorer i forhold til recidiv overgrebsadfærd (Worling & Långström, 2003). Netværket har mulighed for at præge indholdet, hvis der er særlige problemstillinger, som optager dem. Er den unge en del af en uhensigtsmæssig gruppedynamik på skolen, vil deltagende skolepersonale måske gerne skærpe deres viden, om hvad de skal være opmærksomme på, eller måske vil netværket gerne fordybe sig mere i barnets diagnoser samt høre mere om, hvordan de kan komme til udtryk og påvirke den seksuelle adfærd.

Blandt ideer til generelle emner kan nævnes:

- Normativ vs. bekymrende adfærd
- Tilstedeværende risikofaktorer for recidiv overgrebsadfærd
- Dreng- versus pige-klienter
- Den vanskelige samtale med børn og unge, hvor der mistænkes overgreb

Supervision

Supervision giver netværket rum til drøftelse, fordybelse og læring med den behandlingsansvarlige terapeut. Su-

pervisionsgangene kan placeres udvejs i behandlingen med nogle aftaler efter afsluttet behandlingsforløb.

Deltagelse i behandlingen kan åbne for nye ideer, refleksioner og tanker hos netværket, som kan være relevante at sparre omkring og drøfte med den behandlingsansvarlige terapeut. Forældre og professionelle kan give udtryk for deres oplevelse af barnets/den unges udvikling og tilegnelse af redskaber og oplevelse af udviklingen i forhold til den seksuelle adfærd. Der er plads til at oplyse om nye problemstillinger og sammenligne problematikkerne på skolen og i hjemmet. Ved specifikke problemstillinger i de to arenaer, kan det være hensigtsmæssigt at adskille forældre og professionelle, da hver gruppe kan have behov for at drøfte problemstillinger, som kun berører dem. Netværkets betragtninger kan give anledning til planlægningen af temaer for fremtidige behandlingsgange.

Supervisionen giver samtidig mulighed for at sikre, at der er enighed vedrørende indsatsen omkring barnet.

Hvem er netværket?

Barnets/den unges netværk består typisk af forældre, samt de professionelle omkring den unge (JanusCentret, 2015). Det er vigtigt at tage stilling til, hvilke voksne den unge føler sig tryk ved og kan være fortrolig med, samt at størrelsen på den deltagende gruppe er hensigtsmæssig for den terapeutiske proces. Sammensætningen af netværket vurderes individuelt i hver sag, hvor der også lægges vægt på, at der er tale om de samme gennemgående personer, som har mulighed for at deltage

i samtlige behandlingsgange og dermed sikre kontinuitet. Det er ikke i alle netværksforløb, at forældredeltagelse i behandlingsgangene vurderes som hensigtsmæssig. Eksemplet kan være familier, hvor barnet er anbragt og har begrænset kontakt til sine forældre. Det kan her være mere relevant, at der fokuseres på de professionelle, som deler hverdag med barnet/den unge, mens forældrene tilbydes rådgivning sideløbende med netværksforløbet.

Fordele og ulemper ved netværkets involvering

De voksne i barnets/den unges netværk udtrykker ofte en bekymring inden forløbets opstart, om deres tilstedeværelse kommer til at forstyrre behandlingen. De er bekymrede for, at barnet/den unge vil have svært ved at navigere i et rum med flere voksne, og som resultat vil holde tilbage med vigtige oplysninger. Som beskrevet tidligere, tages der stilling til netværkets størrelse og sammensætning. Januscentrets erfaringer med afholdte netværksforløb viser, at barnet/den unge hurtigt vænner sig til behandlingsrammen. Det gøres også tydeligt for barnet/den unge, hvorfor de voksne er til stede og deres tilstedeværelse signalerer engagement, alvoren i barnets/den unges grænseoverskridende adfærd og enighed blandt de voksne om, at der er behov for hjælp.

Et støttende netværk kan udover at bevidne forløbet, bidrage aktivt med eksempler fra barnets/den unges hverdag. De kan referere og, når det er relevant, udfordre og korrigere barnets/den unges beskrivelse af sin adfærd og

vanskeligheder. Netværkets tilstedeværelse gør det ligeledes muligt, at der med det samme kan stilles uddybende spørgsmål til den unge, som de måske længe har undret sig over, eller som barnet/den unge for første gang kommer til at berøre. Det er nemmest for barnet/den unge at uddybe udtalelser og tanker, som han/hun aktuelt er beskæftiget med. Muligheden for at lave aftaler, der er relevante i den unges hverdag, er endnu en gevinst ved netværkets tilstedeværelse. Viser det sig, at der er en særlig situation, der øger risikoen for, at den unge handler grænseoverskridende, virker det oplagt, at den unge kan drøfte med netværket, hvordan man fremover kan forebygge, at den unge befinder sig i denne situation.

En uhensigtsmæssig sammensætning af netværket, kan opfattes som potentiel ulempe. Er der forældre, som negligerer den unges bekymrende adfærd, eller professionelle, der ikke bækker op om øvelserne, kan det have negativ effekt på barnets/den unges udbytte og kan i stedet øge risikoen for recidiv adfærd (Worling & Långström 2003). Dette forsøger man dog at undgå ved at klæde netværket på til opgaven i den forberedende fase.

Temaer i behandlingen

Da netværksforløb i høj grad tilpasses barnets/den unges profil, behov og vanskeligheder, kan der være en stor variation imellem indholdet og øvelserne, som anvendes i forløbet. Der vil derfor aldrig være to forløb, som er helt ens. Det gennemgående er dog, at der lægges fokus på at arbejde med konkrete øvelser og redskaber, som barnet/den

unge forstår, og kan være aktivt deltagende i. Øvelserne vil omhandle faktorer, som øger risikoen for recidiv overgrebsadfærd.

I forhold til en ung, hvor den primære problematik består i vanskeligheder med at aflæse andres grænser, vil man typisk benytte øvelser, der fokuserer på stopsignaler, styrker impulskontrol, giver bedre forståelse for passende versus grænseoverskridende adfærd, samt åbner for drøftelse af redskaber, som den unge kan bruge med netværket.

Handler problematikken derimod om en ung, for hvem det seksuelle er en tvangsinteresse, som eksempelvis startede som et ønske om at opnå kontakt til andre på sociale medier, vil terapeuten i højere grad interessere sig for udløsende faktorer og på at styrke den unge på vej til mere hensigtsmæssig social adfærd. Barnet/den unge og netværket er derfor i høj grad med til at forme forløbet. Det vil hurtigt i forløbet blive tydeligt, hvad barnet/den unge særligt responderer på, hvilket vil blive anvendt i resten af forløbet.

Øvelser i netværksforløb sigter mod at minimere risikofaktorer for tilbagefald i forhold til overgrebsadfærd. Det vil derfor ofte være et vigtigt mål for forløbet at styrke de sociale kompetencer hos barnet/den unge. Unge med særlige vanskeligheder har ofte lavt selvværd og mangler sociale relationer med jævnaldrende (JanusCentret, 2018). Som beskrevet tidligere fortjener social isolation opmærksomhed, da det er en risikofaktor i forhold til overgrebsadfærd (Perry & Orchard, 1992; Epps 1997, Lane, 1997; Bremer, 1998; Ross & Loss, 1999; Långström and

Grann, 2000 og Prentky, Harris, Frizell, & Righthand, 2000).

Unge som ønsker en intim relation kan søge at opnå den gennem en ikke-jævnbyrdig relation, ligesom det ofte ses i legerelationer. En dreng på 13 år, som ikke har alderssvarende sociale færdigheder, vil ofte opsøge yngre børn, som ikke stiller samme krav til socialt samvær. Det samme kan gøre sig gældende i en intim sammenhæng. En dreng på 15 år kan ønske en jævnaldrende kæreste, men hvis det ikke er muligt for ham at få relation til en på 15 år, kan han i stedet rette opmærksomheden mod yngre børn. Søger han seksuelt samvær med et yngre barn, som er under den seksuelle lavalder, og ikke har mulighed for at forstå omfanget og betydningen af det seksuelle, er der tale om adfærd, som der skal handles på.

Udover at være udsatte for at overtræde andres grænser, er børn og unge med nedsat funktionsniveau mere udsatte for selv at blive ofre for seksuelt grænseoverskridende adfærd (Holt, Christoffersen, Poulsen, Bengtsson & Bach, 2017). Ønsket om at indgå i en relation og blive inviteret i et socialt netværk og få opmærksomhed kan gøre det svært for ensomme børn og unge at sige "nej" til opfordringer til uhensigtsmæssig adfærd. Unge med alvorlig svækket kognitiv funktion kan have vanskeligt ved at forstå konsekvensen af deres handlinger og ved at forstå andres bevæggrunde. Men selv de unge, som godt ved, at de relationer, de indgår i, ikke er hensigtsmæssige, kan af frygt for isolation vælge at gå på kompromis med egne grænser. Case 1 beskriver et af de tilfælde.

Alt dette er der mulighed for at arbejde med i et netværksforløb, hvor netværket bliver klædt på i forhold til, hvordan de kan støtte barnet/ den unge i hverdagen.

Case 1

14-årig Kathrine bor på et opholdssted. Hun er tidligere blevet udsat for massivt omsorgssvigt og har fået stillet en ADHD- og tilknytningsdiagnose. Personalet på opholdsstedet er bekymrede for, at Kathrine på baggrund af sin adfærd kan blive offer for seksuelt overgreb. Det beskrives, at Kathrine har meget vanskeligt ved at indgå i relationer med jævnaldrende. Når det lykkes, kommer hun meget hurtigt i konflikt med dem. Kathrine er begyndt at tage seksualiserende billeder af sig selv og lægge dem på nettet. Selvom personalet prøver at tale med Kathrine om adfærden, er det meget svært for hende at stoppe, da hun på den måde får opmærksomhed og oplever, at hun har et socialt netværk.

Hvordan kan barnet/den unge drage nytte af netværksforløb

Det er erfaringen på JanusCentret, at høj involvering af konkrete øvelser som fælles 3. hjælper barnet/den unge til en bedre forståelse af sin problematik, samt til udvikling af mere normativ seksuel adfærd.

Mange børn og unge, som henvises til JanusCentret, har vanskeligt ved at arbejde fokuseret med den seksuelt grænseoverskridende adfærd, da den ofte er forbundet med følelser af skam (Worling & Långström 2003). Det kan her være behjælpeligt i behandlingen at adskille dem som person fra deres

adfærd, for at muliggøre det videre arbejde med de seksuelle problematikker. Til dette formål bruges en ekster-naliserende øvelse, hvor barnet/ den unge bedes om at tegne den del af sig selv, som giver lysten til at begå den problematiske adfærd. Når deres impulser adskilles på den måde, er det erfaringen, at selv børn med massive udviklingsmæssige vanskeligheder kan fortælle meget relevante oplysninger om deres adfærd og de faktorer, der udløser dem. Denne viden er en nødvendighed i forhold til at kunne finde frem til relevante overgrebsforebyggende redskaber.

Et netværksforløb giver også barnet/ den unge mulighed for at vænne sig til at tale om den grænseoverskridende adfærd med de nærmeste voksne. Det kan opleves som en fordel, at de er samlet, så de alle er med til at høre barnets/den unges beretning.

Det understreges for barnet/den unge i netværksforløbet, at alle tilstedeværende er der for at hjælpe ham/ hende med at ændre den uhensigtsmæssige adfærd, som for de flestes vedkommende har ført til irrettesættelser og andre negative konsekvenser. Flere børn og unge har udtrykt i løbet af et netværksforløb, at de ikke har følt sig i stand til at ændre deres adfærd på egen hånd. Synliggørelse af den fælles indsats virker for dem motiverende og styrker dem i troen på, at de i fællesskab med de voksne kan bryde egne mønstre. Dette kan potentielt bringe barnet/den unge tættere på netværket og forbedre relationen til omsorgspersoner.

Rammen og indholdet af netværksforløb tilbyder det henviste barn/ung at

blive klogere på sig selv, opleve større sammenhæng mellem sine tanker, impulser og adfærd, samt opleve støtte og fællesskab med sit netværk. Barnet/ den unge kan opleve sig taget alvorligt og lyttet til og blive bedre til at fortælle om sine vanskeligheder. Dette kan give ham/hende en større følelse af ejerskab og ansvar i forhold til at ændre den uhensigtsmæssige adfærd. Som resultat af dette har de deltagende børn og unge ofte rapporteret om, at de har de fået det bedre sammen med deres jævnaldrende og voksne. De oplever færre konflikter og føler, at de er bedre i stand til at undgå nye grænseoverskridende episoder.

Citater fra børn, der beskriver deres udbytte af netværksforløbet:

“Jeg tænker ikke så meget på sex mere. Jeg tænker på traktorer og den slags i stedet for” (dreng 11 år)

“Jeg blev lyttet til. Jeg blev taget seriøst” (dreng 9 år)

“Jeg har lært ikke at tænke så meget på sex, ikke røre ved andre de frække steder, slet ikke børn” (dreng 12 år)

“Jeg har fået snakket om en masse ting, der har været svære for mig at snakke om” (dreng 10 år)

“Jeg har lært mere om mig selv. Hvad jeg synes er ok og hvad der ikke er ok. Jeg har lært, at der er dårlige hemmeligheder og gode hemmeligheder. Dårlige hemmeligheder kan gøre ondt i maven” (dreng 9 år)

Hvad får netværket ud af forløbet

Netværksforløb stiller høje krav til barnets/den unges netværk, men tilbyder til gengæld vigtig viden og opkvalificering. Netværket kan forvente en bedre forståelse af den seksuelle udvikling, samt den problematiske adfærd, som er målet for forløbet.

Deltagelsen i netværksforløb kan både afdække baggrunden for kendte problemstillinger og afklare misforståelser, som netværket tidligere ikke har været bevidst om. Det kan blandt andet vise sig, at netværket uden at være klar over det, har bidraget til den problematiske adfærd. Følgende cases illustrerer, hvordan netværksforløb kan danne rammen for at styrke netværkets forebyggende indsats og øge deres forståelse af baggrunden på den uhensigtsmæssige adfærd.

Case 2

En 11-årig dreng med udviklingshæmning er gennem det sidste år begyndt at udvise grænseoverskridende adfærd over for personalet på hans specialskole. Han tager kvindeligt personale på brysterne og kan finde på, at tage mændene på maven eller prikke til deres bagdel. Dette forekommer især, når han er i en friere ramme, uden fast struktur. Når adfærden omtales i netværksforløbet forklarer drengen, at han tilfældigt fandt ud af, at det var en meget hurtig måde at få opmærksomhed på. Han er egentlig ikke motiveret af det seksuelle. Indsatsen her fokuserer på at lære ham hensigtsmæssige måder at tage kontakt på, som kan erstatte det gamle mønster.

Case 3

10-årig Jonas med autisme diagnose er blevet taget i at se porno. Hans netværk har også observeret, at han er begyndt at tale seksualiserende og hans viden og udtalelser overstiger, hvad der forventes i hans aldersgruppe. Det er oplevelsen, at det at se porno er lystbetonet for Jonas og det er hverken lykkedes hans forældre eller professionelle at få ham til at holde op. Under netværksforløbet viser det sig, at Jonas er blevet introduceret til porno af en ældre fætter og det er sidenhen blevet til en særinteresse. Jonas beskriver i løbet af netværksforløbet, at det er meget svært for ham ikke at tænke på porno, men han vil selv gerne kunne være fri for det.

Det er erfaringen, at fælles deltagelse giver netværket et særligt, fortroligt rum med barnet/den unge, hvorfor de ofte oplever, at de har fået en tættere relation til barnet/den unge. Ikke alle professionelle og forældre føler sig klædt på til at spørge til det seksuelle. Da seksualitet er en naturlig del af netværksforløb, har flere deltagere rapporteret efter afsluttet forløb, at de har fået konkrete ideer til, hvordan de skal tale med barnet/den unge om det seksuelle, og hvordan de kan spørge så barnet/den unge er i stand til at besvare deres spørgsmål.

Netværksforløb skaber grundlaget for det videre arbejde med barnets/den unges seksuelle adfærd i deres naturlige miljø. Den aktive deltagelse i forløbet gør det nemt at henvise til de lærte redskaber og øvelser, som har været anvendt i forløbet, når barnet udviser bekymrende adfærd (JanusCentret, 2015).

Netværksforløb giver de voksne, både professionelle og forældre, yderligere mulighed for at danne en samlet indsatsstyrke, som har til formål at hjælpe barnet/den unge bedst muligt og samtidig signalere, at der er hjælp at hente.

Citater fra netværket, som beskriver deres udbytte af forløbet:

“Jeg rummer barnet meget bedre”
(skolepædagog)

“Klar og tydelig forståelse for barnets udfordringer i det sociale felt. Gode, konkrete redskaber til brug i det daglige arbejde med barnet” (lærer)

“Jeg har fået “værktøjer” og inspiration til at gå i dialog med mit barn om vanskeligheder, ikke kun af seksuel karakter” (far)

“Tættere bånd til netværket og redskaber til at arbejde ud fra” (skolepædagog)

“Større indsigt i den unges verden”
(lærer)

“Der er jo masser at gøre for at afhjælpe vores barns seksualiserede udvikling. Men derudover fik vi også hjælp til at udvikle på vores samspil og hans udvikling i øvrigt” (mor)

PPRs involvering i netværksforløb

PPR kan blive involveret i indsatsen omkring et netværksforløb både før, under og efter det afsluttede behandlingsforløb. Som det tidligere blev beskrevet, kan skolepersonale og forældre have behov for et par friske øjne til

at se på problematikken, da man efter længere tid, kan opfatte det bekymrende som en naturlig del af barnets/den unges adfærd. PPR kan her tjene med deres viden og kompetencer, når der hersker tvivl omkring bekymringsgraden i barnets/den unges seksuelle adfærd. Case 4, viser hvordan PPR kan bidrage med relevante observationer.

Case 4

12-årig Ellen ankommer til PPR kontoret. Ellen er anbragt på et opholdssted, hvor man har oplevet hende være seksualiserende overfor mandligt personale. Hun kan også finde på at sende nøgenbilleder af sig selv til drenge fra skolen. PPR-psykologen kan høre Ellen tale meget højt til sin kontaktpædagog. Hun fortæller pædagogen om en dreng, hun er forelsket i og bruger flere seksualiserende udtryk. Ved en senere samtale fortæller kontaktpædagogen adspurgt, at der ikke fokuseres på Ellens sprog, da det er noget hun altid har gjort, og personalet har fokuseret på hendes andre problematikker.

Netværksforløb profiterer ikke udelukkende af PPRs kompetencer, men det åbner også for muligheden for en aktiv deltagelse. Ansatte ved PPR vil almindeligvis ikke deltage i behandlingsgangene, da deres daglige kontakt med barnet/den unge ofte vil være sparsom. Det vil være oplagt for PPR at deltage i undervisningen og supervisionen. De vil på den måde kunne få mulighed for opkvalificering i forhold til den konkrete problemstilling og opnå viden, som ofte vil være anvendelig i en række andre tilfælde med seksuelt grænseoverskridende adfærd. PPR kan være del-

tagende i forhold til at forme spørgsmål til undervisningen og i supervisionsdelen. Den aktive deltagelse giver samtidig PPR mulighed for et tæt samarbejde med andre professionelle omkring barnet/den unge samt med forældrene. På den måde sikres PPR overblik over indsatsen, hvor de forberedes til at kunne påtage sig en vejledende rolle fremover. Da netværksforløb er en fokuseret indsatspakke vil den forsøge at afdække de relevante elementer af problematikken for netværket og give dem samt barnet/den unge relevante værktøjer. Den begrænsede tids- og indsatsramme sammenholdt med problematikens omfang vil ofte betyde, at der vil være behov for at følge barnets/den unges seksuelle udvikling og adfærd, samt evaluere den nødvendige indsats.

PPR kan derved spille en vigtig rolle efter afsluttet forløb i forhold til den videre vejledning af forældre og professionelle. Skolepersonale kan have behov for hjælp i forhold til videreformidling af de anvendte redskaber og viden, samt til opfølgning på afsluttende anbefalinger. Ved at have været aktivt deltagende i forløbet, vil PPR besidde væsentlig viden om barnet/den unge, som kan være yderst relevant at medtænke eller videreformidle, hvis der opstår andre problematikker, der relaterer sig til barnets/den unges adfærd og trivsel.

Konklusion

National og international forskning beskriver en række risikofaktorer, som er vigtige at arbejde med for at forhindre recidiv overgrebsadfærd hos unge. Det er ligeledes vigtigt at inddrage barnets/

den unges omsorgspersoner i behandlingen.

Netværksforløb er et særligt behandlingstilbud til børn og unge med seksuelt grænseoverskridende eller bekymrende adfærd, som egner sig til børn og unge med nedsat funktionsniveau. Metoden skiller sig ud ved at inddrage barnets/den unges voksne og professionelle netværk i behandlingen, og der lægges fokus på at opkvalificere netværket for at give dem de bedste forudsætninger for det fortsatte arbejde med den uhensigtsmæssige adfærd.

De kvalitative data fra netværksforløb viser, at der er hjælp at hente for børn og unge med mental udviklingshæmning og neuropsykiatriske diagnoser, som udviser seksuelt grænseoverskridende adfærd, hvilket understreger vigtigheden af, at der rettes opmærksomhed mod denne gruppes seksuelle udvikling og adfærd.

Netværksforløb tilbyder det delta-gende netværk opkvalificering gennem undervisning, supervision og konkrete værktøjer, som der arbejdes med i behandlingsgangene. Netværket har rapporteret, efter endte forløb, at de har fået brugbare værktøjer og viden om den seksuelle adfærd. Flere rapporterer om positiv udvikling hos det delta-gende barn/ung, både i forhold til den seksuelle adfærd og anden uhensigtsmæssig adfærd.

Børn og unge rapporterer selv om, at de har fået brugbare, overgrebsforebyggende værktøjer.

PPR kan spille en vigtig rolle i processen både inden, under og efter et endt behandlingsforløb, hvorfor der opfordres til, at der rettes fokus på den seksuelle udvikling blandt udsatte

børn og unge med nedsat funktionsniveau, som har øget behov for professionel omsorg. Den gruppe børn og unge er ikke alene i fare for at udvise seksuelt grænseoverskridende adfærd qua deres vanskeligheder, men de er samtidig i større fare for at komme i situationer, hvor deres egne grænser kan blive overtrådt. Derfor har deres netværk behov for særlige kompetencer og viden, hvilket opnås bedst gennem samlet indsats for omsorgspersoner og professionelle voksne.

Referencer

- Amand, A. St., Bard, D. E., Silovsky, J. F. (2008). Meta-Analysis of Treatment for Child Sexual Behavior Problems: Practice Elements and Outcomes. *Child Maltreatment, 13*, 145-166
- Bremer, J. F. (1998). Challenges in the assessment and treatment of sexually abusive adolescents. *Irish Journal of Psychology, 19*, 82-92.
- Calder, M. C., Hanks, H., Epps, K.J. (1997). *Juveniles and children who sexually abuse. A guide to risk assessment*. Lyme Regis, U. K.: Russell House Publishing.
- Epps, K. J. (1997). Managing risk. I M. S. Houghugh, S. R. Bhate & F. Graham (Red.), *Working with sexually abusive adolescents*. (pp.35-51). London: Sage.
- Holt, H., Christoffersen, M., Poulsen, M., H., Bengtsson, S. & Bach, H., B. (2017). *Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap*. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
- JanusCentret (2015): Statusrapport XII 2003-2014
- Januscentret (2016). *Bekymringsbarometer*. Lokaliseret den 22. Marts 2019 på: http://januscentret.dk/wp-content/uploads/Januscentret_bekymringsbarometer_2016.pdf
- JanusCentret (2017): Statusrapport XIII 2003-2016
- JanusCentret (2018): Statusrapport XIII 2003-2017
- Kahn, T. J., & Chambers, H. J. (1991) Assessing reoffense risk with juvenile offenders. *Child Welfare, 70*, 333-345.

- Kar S. K., Choudhury A., Singh A. P. (2015), Understanding normal development of adolescent sexuality: A bumpy ride. *Journal of Human Reproductive Sciences*, 8 (2), 70–74.
- Lane, S. (1997). Assessment of sexually abusive youth. I G. Ryan & S. Lane (Red.), *Juvenile sexual offending: Causes, consequences, and correction* (revideret udgave) San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 219-263.
- Långström, N. & Grann, M. (2000). Risk for Criminal Recidivism among Young Sex Offenders. *Journal of Interpersonal Violence*, 15, 855-871.
- Lipsey, M. W., & Derzon, J. H. (1998). Predictors of violent or serious delinquency in adolescence and early adulthood: A synthesis of longitudinal research. In R. Loeber & D.P. Farrington (Eds.), *Serious and violent juvenile offenders: Risk factors and successful interventions* (pp. 86-105). London: Sage.
- Perry, G. P., & Orchard, J. (1992). *Assessment and treatment of adolescent sex offenders*. Sarasota, FL: Professional Resource Exchange, Inc.
- Prentky, R., Harris, B., Frizzell, K., & Right-hand, S. (2000). An actuarial procedure for assessing risk with juvenile sex offenders. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 12, 71-93.
- Red Barnet. (2015). *Hvor slemt ka' det være? En antologi om it-relaterede seksuelle overgreb* (1. udgave). København, Red Barnet.
- Ross, J., & Loss, P. (1991). Assessment of the juvenile sex offender. I G. D. Ryan, & S. L. Lane (Red.), *Juvenile sexual offending: Causes, consequences, and correction* (199-251). Lexington, MA: Lexington Books.
- Worling, J. R. (2001) Personality-Based Typology of Adolescent Male Sexual Offenders: Differences in Recidivism Rates, Victim Selection, Characteristics, and Personal Victimization Histories. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, Vol. 13, No. 3, 149-166.
- Worling, J. R., & Curwen, T. (2001) Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism (The ERASOR- Version 2.0). In M. C. Cader (Ed.), *Juveniles and children who sexually abuse: Frameworks for assessment* (pp. 372-397). Lyme Regis, U.K.: Russell House Publishing